

Si tu regardes l'origine embryologique du foie, il est fait de trois parties. Une partie qu'on appelle l'intestin supérieur, une partie qu'on appelle l'intestin moyen, et une partie qu'on appelle l'intestin inférieur. La jonction entre l'intestin supérieur et l'intestin moyen, ici, il va y avoir ce qu'on appelle un phénomène d'aspiration. Donc, un champ métabolique, qu'on appelle un champ métabolique de loosening fields. Ça veut dire un champ d'aspiration. Si je prends une coupe ici, comme ça, et je prends ici, et je vois ce tissu, je le dessine comme ça. On voit que c'est un ensemble de cellules. En dessous, j'ai du tissu d'intérieur, mésodermique. Entre autres, ce sera tout le système artériel plus tard, du foie. N'oubliez pas que le système artériel du foie vient de mon système essentiel. C'est un système essentiellement fitellin. Je vois à un moment donné qu'il y a le tissu qui est comme aspiré, et ça fait un mouvement comme ça. C'est le même protocole de développement pour toutes les glandes. Et puis, à un moment donné, tu vois que ceci, tu as fait ça, et il commence à se fractaliser, si je peux dire. Et à former de plus en plus. Et chaque petit bougonnement va refaire un nouveau champ d'aspiration ici. Et ça va former un ensemble de petits canaux qu'on appelle les canaux hépatiques. On a deux types de glandes, une glande exocrine et une glande endocrine. Ici, le foie, c'est une glande exocrine. Parce que si c'est une glande endocrine, le système perd sa lumière et secrète sa substance dans le sang, endocrine. Tandis que là, elle secrète son système biliaire à l'intérieur de la lumière. Et donc, renvoie ici, tu vois, renvoie dans le système ici. Qui sont tout ce qui est des sucres pour la digestion, etc. Et là, on rentre dans des détails. Donc, il faut bien comprendre que le foie, c'est un champ d'aspiration. Qui va se mêler, sur le plan mésodermique, avec un ensemble de vaisseaux d'origine viteline, et qui vont former tout ce processus du foie. C'est juste de l'intestin qui s'est complètement... Mais en plus, il s'est mis avec du mésoderme. Et en plus, comme il s'est mis avec du mésoderme, il a

cette fonction à la fois mésodermique, et cette fonction à la fois endodermique. La fonction endodermique, c'est une fonction de type digestif, de type canobilière spécialisée, avec le cycle entérohépatique, qui est très important, avec cette relation où il va sécréter cette bile qui va être résorbée au niveau sécal. Vous connaissez ce cycle, c'est un cycle important. Et une autre fonction, qui est une fonction endocrine, par mon système mésodermique. Donc, deux types de fonctions. Et quand on enlève une partie du foie, admettons que je coupe cette partie-ci, en fait, il se régénère, mais il se régénère dans sa structure mésodermique. Pour avoir un champ d'aspiration, il faut que j'ai une phase de croissance longitudinale de l'embryon. Donc, son champ est un champ d'aspiration lié à la croissance. Donc, c'est un mouvement qui est lié à la fois au processus de céphalisation, de cardialisation et d'hépatisation. Il faut retenir que la fonction primaire du foie sera au départ essentiellement hémodynamique. Il va permettre un potentiel de vie. En plus, dans son premier impulse, il est formé par les produits de désassimilation. Ça veut dire que sa première information est de recevoir les produits cataboliques de l'ensemble du corps. Et après, il passera. Donc, il est fait dans sa structure, presque, pour recevoir ça et donc pouvoir participer à la régénération. Ça veut dire que dans son processus, le foie est l'organe qui est le principal organe régénérateur de votre corps. Aussi bien sur un plan tendineux, aussi bien sur un plan musculaire, aussi bien sur d'autres petits plans de la structure. Une des structures anatomiques qui a le plus de pouvoir de vous régénérer. Ça donne un potentiel et il va recevoir des informations portales, lymphatiques et cardiaques. Sur le plan ostéopathique, s'il perd son intégrité fonctionnelle avec le diaphragme, n'oubliez pas que le ligament triangulaire, le ligament falciforme, cette enveloppe du foie, est en continuité tissulaire, cellulaire et même moléculaire avec le diaphragme et le péricarde. Et qu'il a cette origine au-delà de

la plaque précordale. Et qu'on voit qu'il y a des cellules qui sont au-delà de la plaque précordale ici. C'est un mésenchymes indifférencié au départ. Mais qui vont donner à la fois le septum transversum et le péricarde. Et que le septum transversum va entre autres donner ce qu'on appelle le triangulaire du foie qui continue par le ligament falciforme hépatique. Il va aussi avoir une information pour le grand épiploon, le grand omentum. Le cœur, le diaphragme et la partie du foie sont reliés. Donc, ça veut dire ici, ce qui est important, c'est que c'est un point d'appui qui participera indirectement à donner plus tard les piliers diaphragmatiques. Je vois que le septum transversum est ici, on va dire. Comme c'est ici, avec le péricarde. Eh bien, si on voit qu'on fait marche arrière, j'ai ces cellules ici. Eh bien, le système ici ne bouge pas. Et c'est tout le système autour qui croit comme ça. Et ce qui fait que c'est cette intégration qui va se faire par le mouvement développemental du cerveau. Quand je prends, en fait, la base ici, quelque part, je suis sur un point d'appui original. Ce fulcrum, on peut dire, j'aime préférer le mot, un point d'appui. On va pouvoir aider un foie déjà en donnant une bonne intégrité. Donc, un simple déplacement costal peut changer la position de mon diaphragme et de mon foie. Le diaphragme, c'est toujours ce qu'on appelle la porte de la vie vis-à-vis de ses orifices libres. Cette notion qui est très importante pour le foie, c'est cette notion par rapport au diaphragme. Et le diaphragme, qu'est-ce qu'il fait ? C'est un mouvement qui est rythmique. On fait 23 000 respirations par jour. Ça veut dire que dans sa fonction, le foie, dans son travail, est dépendant du mouvement des poumons, donc du mouvement diaphragmatique. On a une pression de type négative au niveau pulmonaire et on a une pression de type plutôt positive au niveau abdominal. Ici, on va retrouver une pression négative au niveau pelvien. Et tout en haut, on va retrouver une autre congestion positive. La normotension abdominale, c'est une référence qui est intéressante pour nous. Ça

veut dire que la tension épigastrique est légèrement supérieure à la tension hypogastrique. Ça, c'est ma normotension. Si maintenant, j'ai une hypertension abdominale très fréquente, j'augmente ici, donc je perds ma force ici. Ça veut dire que traiter cette zone-ci sera toujours aller voir ma grande zone dépressive. Ça veut dire que traiter les poumons, c'est retraiter le péritoine. Si j'ai une déstabilisation de l'un, je perds l'autre. Donc ça veut dire que non seulement je peux le travailler là, mais je dois le travailler dans des espaces de volémie. Donc comment on peut soutenir tout ce processus diaphragmatique ? Ne pas oublier que non seulement ici, vous avez le foie qui est énorme, mais en dessous ici, vous avez une grande partie à la fois avec le cœur ici et avec les poumons ici, dans un espace d'échange important. Il faudra pouvoir déjà déterminer quel type de tension tu vas retrouver dans ton abdomen. Travaille sur des schémas volémiques. Donc ce sera important de soutenir ici parce que si tu perds ta fonction ici, tu vas diminuer ta vitalité ici. Le diaphragme, il va essayer de tenir. Deuxième chose, c'est les qualités vis-à-vis des liquides qui sont échangés. Une qualité de type digestif, par exemple, ou une qualité de volume qui doit se faire. Donc le foie, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va quantifier et il va modifier la tension portale qu'il va transmettre au cœur. Le foie n'est qu'une spécialisation du diodénum, en fait, qui, lui, reçoit le plus d'informations de type autocrine, paracrine, neurocrine, endocrine, c'est-à-dire que c'est un carrefour d'informations à la fois pour ton pancréas, pour ton foie, pour tout ce que tu veux, qui va donner l'information de type digestive en fonction de ce que tu vas recevoir. Donc ça veut dire que c'est un état de volume qui va s'exprimer par rapport à ça, par une quantité spécifique. Donc il faut que j'ai un état digestif qui soit de plus en plus adéquat. Ça veut dire que, de nouveau, je remonte autocrine, paracrine, digestif. Donc quand le foie va arrêter tous ces mouvements, il va perdre la qualité de ces échanges, à la fois aussi sur

le plan lymphatique, n'oubliez pas, et alors là, ça va déstabiliser ton cœur. Ça peut rendre le cœur malade. Donc on peut presque dire qu'il y a une relation très importante entre le cœur et le foie. Si ton foie commence à déstabiliser, c'est là où le cœur devient malade. Donc si ton cœur commence à être malade, ben, va surtout soulager ton foie. La plupart des temps, les états du cœur ne sont qu'une dysfonction métabolique du foie. Le foie aussi peut surcharger le système lymphatique, qui va surcharger le système du canal lymphatique, qui va surcharger tout le plexus neurologique latéral de la chaîne sympathique, qui va se répercuter à distance. Une épaule à gauche peut être le reflet d'une congestion hépatique. Ce sont les premiers signes d'un dérèglement du foie. Le grand conduit primaire est d'abord à gauche. Il ne faut pas oublier non plus cette trinité cœur-le-foie-la-rate. Et moi, je rajoute encore le système ésentérique. Ces éponges, ces états de volaimie, ils fonctionnent ensemble. Ils se soutiennent comme on peut. Puis n'oubliez pas que l'axe entre le foie et le cœur, c'est la veine cave. C'est la veine supérieure qu'on a vue hier, comment elle se construisait. On peut parler encore de toute cette relation immunitaire avec le système thymique. Lymphocyte T, ce passage avec le thymus et tout ce retour par la rate, sur le plan des informations immunitaires qui se fait par le foie, et de retour sur le système de la rate avec l'équilibre thymique, qui vient informer les lymphocytes en lymphocyte T, etc.